

Usuwanie zachowań zabezpieczających

Eksperyment: co stanie się, gdy zrezygnuję z „kuli” ochronnej? Pacjent sam sprawdza, że żyje nie dzięki nim — lecz mimo ich braku.

CZAS: 20 min na eksperyment 1 zachowanie / tydzień, 5–10 powtórzeń

ŹRÓDŁO: Salkovskis (1991, 1999, RCT); Wells (1995); Craske & Barlow (2007)

JAK UŻYWAĆ

Wybierz **jedno** zachowanie zabezpieczające z hierarchii (zaczniј od najłatwiejszego). Zapisz prognozę: „bez X stanie się Y, z pewnością Z%”. Wejdź w sytuację *bez tego konkretnego zabezpieczenia*. Zapisz wynik i nową pewność. Powtórz 5× w różnych kontekstach przed przejściem do następnego SB. Najtrudniejsze (lek ratunkowy) — dopiero w fazie utrwalenia.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Każde bezpieczne zakończenie sytuacji bez *aktywnego testu* zostaje przypisane zabezpieczeniu: „żyję, bo siedziałem/-am przy wyjściu”, „przeżyłem/-am, bo miałem/-am lek”. Atrybucja blokuje uczenie. Eksperyment forsuje dysonans między prognozą („umrę”) a realnym wynikiem („nie umarłem/-am”) — bez zabezpieczenia mózg **musi** zaktualizować przekonanie. Wells i wsp. (1995): usunięcie nawet *jednego* zachowania zabezpieczającego daje znaczący spadek lęku.

01 ☉ Trzy typowe eksperymenty — od łatwego do trudnego

EKSPERYMENT	ZACHOWANIE DO PORZUCENIA	TYPOWA PROGNOZA (PEWNOŚĆ)	TYPOWY WYNIK PO SPRAWDZENIU
1 • Łatwy	Telefon: jazda autobusem 3 przystanki bez telefonu przy uchu / w ręku.	„Dostanę ataku i nikt nie pomoże” 75–85%	SUDS sięga 50, opada do 20 do końca przejazdu. Nikt nie był potrzebny.
2 • Średni	Unikanie kawy: świadome wypicie 1 filiżanki kawy i obserwacja objawów przez 30 min.	„Kołatanie od kawy → atak paniki” 60–75%	Tętno wzrasta o 10–15/min. Bez ataku. Kawa wywołuje objaw, nie panikę.
3 • Trudny	Bez leku ratunkowego: wyjście z domu bez alprazolamu / lorazepamu w torebce.	„Bez leku nie przeżyję ataku” 80–95%	Możliwy podwyższony lęk antycypacyjny. Atak (jeśli wystąpi) nadal trwa 20–30 min i mija sam.

Eksperyment 3 jest najtrudniejszy i wykonuje się go zwykle dopiero po kilku udanych ekspozycjach 1 i 2. Posiadanie leku może utrzymywać przekonanie „mogę potrzebować ratunku” jeszcze długo po klinicznej poprawie — dlatego ten krok wymaga osobnego przygotowania.

02 💡 Pytania debriefingu po eksperymentcie

1. Kto mnie uratował? Lek? Telefon? Czy może *nic się nie stało*?

2. Co się stało naprawdę? Konkret, nie ogólnie. SUDS w czasie, czas trwania.

3. Czy prognoza się sprawdziła? 0/1. Częściowo? Wcale? Co dokładnie?

4. Co teraz wiem o tej sytuacji? Wniosek strukturalny, nie „szczęście”.

03 Dziennik eksperymentów — 6 porzuceń

Po każdym eksperymencie wypełnij wiersz. Trzy eksperymenty „bez tego samego” zaplanuj w różnych kontekstach (pory, miejsca, stany ciała).

#	DATA	PORZUCONE SB <i>co dokładnie nie wziąłem/-am</i>	PROGNOZA <i>„bez X stanie się Y”</i>	WIARA PRZED	CO STAŁO SIĘ NAPRAWDĘ	WIARA PO	SUDS MAX
1							
2							
3							
4							
5							
6							

04 Wniosek po 6 eksperymentach

ILE RAZY PROGNOZA SIĘ SPEŁNIŁA?

— policz z tabeli

ŚREDNIA ZMIANA WIARY

— przed minus po, średnio

CO TERAZ WIEM O ROLI ZACHOWAŃ ZABEZPIEZAJĄCYCH W MOIM LĘKU?

— wyjaśnienie strukturalne, nie „szczęście”

Klucz: Salkovskis i wsp. (1999, randomizowane badanie kliniczne): terapia poznawczo-behawioralna bez eliminacji zachowań zabezpieczających jest **istotnie mniej skuteczna** od wersji pełnej. Zachowania zabezpieczające to „niewidoczne kule” — pacjent nie wie, że chodzi sam. Często przypisuje im magiczną moc („bez alprazolamu umrę”), nawet gdy *nie używał/-a leku od miesięcy*. Celem jest empiryczne sprawdzenie tej hipotezy, nie obalenie argumentem.